

BILAG 2

Leverandørens beskrivelse av løsningen

Sørvik Helsepartner HF - klinisk samhandlingsplattform

Kunde	Sørvik Helsepartner HF
Anskaffelse	Integrasjons- og samhandlingsplattform for pasientforløp og hjemmeoppfølging
Kontraktsmønster	SSA-T 2026 med påfølgende SSA-V
Dokumentdato	30. juli 2026
Status	Tilbudsbesvarelse fra MedNexus Nordic AS - fiktiv testversjon

Fiktivt testgrunnlag

Alle virksomheter, leverandører, tall og avtaler i dokumentet er fiktive. Dokumentet er konstruert for funksjons-, parser- og kvalitetsprøving.

1. Tilbudt løsning

CareFlow Nexus En norsk, hendelsesdrevet klinisk integrasjonsplattform med FHIR R4, varig meldingsformidling, behandlingsrelasjonsbasert tilgang og et eksplisitt revisjonsspor fra hjemmemåling til journalført handling.

Leverandørens hovedforpliktelse

Løsningen leveres med dokumenterte akseptansekriterier, sporbare forutsetninger og en tilbakefallsplan for hver risikoutsatt overgang.

2. Målarkitektur

- FHIR-gateway og adapterlag mot EPJ, kurve, laboratorium, kjernejournal og kommune.
- Varig meldingskø med idempotens, kvittering og klinisk avviskskø.
- Versjonert regelmotor for klinisk varsling og eskalering.
- Policybasert tilgang med behandlingsrelasjon og kontrollert nødtilgang.
- Separate observabilitetsflater for teknisk drift og klinisk forvaltning.

3. Gjennomføring og verifikasjon

- Prioritert integrasjonskartlegging og kontrakttester.
- Parallellkjøring og avstemming før hver gammel kobling stenges.
- Stille pilot, begrenset klinisk pilot og gradvis skalering per forløp.
- Feilscenarier og full gjenoppretting som obligatorisk akseptanse.

4. Krav-for-krav-besvarelse

Alle A-krav bekreftes oppfylt med mindre annet er angitt. Svarene nedenfor er bindende del av den fiktive tilbudsbesvarelsen.

Krav-ID	Pri.	Kundens krav	Leverandørens bindende svar
SOR-PAS-01	A	Meldingssikkerhet Bekreftede kliniske meldinger skal formidles nøyaktig én gang eller håndteres idempotent, med kø, kvittering, korrelasjons-ID og synlig avviskskø.	CareFlow Nexus bruker varig meldingskø, idempotensnøkkel og ende-til-ende-kvittering. Hver melding får korrelasjons-ID og tilstandslogg. Meldinger som ikke kan leveres går til en klinisk avviskskø med eier, prioritet og kontrollert ny behandling.
SOR-FHIR-02	A	Standarder Plattformen skal støtte HL7 FHIR R4 og bevare originalmelding og transformasjonsversjon for revisjon.	FHIR R4 støttes gjennom profilerte ressurser og validering mot avtalte implementasjonsguider. Originalmelding, transformert nyttelast, mappingversjon og valideringsresultat lagres som ett revisjonsspor.
SOR-IAM-03	A	Tilgang Tilgang til pasientdata skal kreve tjenstlig behov, klinisk rolle og aktiv behandlingsrelasjon. Nødtilgang skal begrunnes og etterkontrolleres.	Policykontrollen kombinerer rolle, organisasjonsenhet, aktiv behandlingsrelasjon og formål. Nødtilgang krever oppgitt begrunnelse, gir sanntidsvarsel og sendes til etterkontroll. Alle oppslag inngår i en uforanderlig revisjonslogg.
SOR-VAR-04	A	Klinisk varsling Kritiske hjemmemålinger skal vurderes mot versjonerte regler og varsles til riktig klinisk team med eskalering når varselet ikke kvitteres.	Målinger valideres før en versjonert regelmotor klassifiserer dem. Varselet rutes etter pasient, forløp og vaktplan, med kvitteringsfrist og trinnvis eskalering. Regelversjon, måling, mottaker og handling kan rekonstrueres.
SOR-PAS-05	B	Pasientinnsyn Pasienten bør kunne se mottatte målinger, status og kontaktinstruks uten å få presentert automatiske vurderinger som medisinsk diagnose.	Pasientflaten viser måling, mottakstid, status og godkjent kontaktttekst. Kliniske regler og interne risikoscorer vises ikke som diagnose. Tekster forvaltes av helseforetaket og versjoneres.

Krav-ID	Pri.	Kundens krav	Leverandørens bindende svar
SOR-LOG-06	A	Sporbarhet En klinisk beslutningskjede skal kunne spores til kilde, tidspunkt, regelversjon, transformasjon og ansvarlig helsepersonell.	En sammenhengende sporingsmodell kobler originalmåling, transformasjon, regelkjøring, varsel, kvittering, klinisk vurdering og journaloppdatering med samme korrelasjons-ID. Revisjonsvisningen kan eksporteres til tilsyn og hendelsesanalyse.
SOR-DRI-07	A	Kontinuitet Kritisk meldingsformidling skal ha 99,95 prosent tilgjengelighet, RPO null for bekreftede meldinger og RTO høyst 60 minutter.	Tjenesten tilbys aktivt fordelt mellom to norske tilgjengelighetssoner. Bekreftede meldinger replikeres synkront før kvittering, som gir RPO null. Automatisert gjenoppretting og kvartalsvis øvelse dokumenterer RTO under 60 minutter.
SOR-DAT-08	A	Datalokasjon Pasientdata, sikkerhetskopier og identifiserbare driftslogger skal behandles i Norge.	Alle tre datakategoriene lagres og behandles i norske regioner. Leverandørtilgang er tidsbegrenset, godkjent og logget. Underleverandørregisteret viser tjeneste, dataart og behandlingssted.
SOR-MIG-09	A	Integrasjonsmigrering Minst 30 av 74 punkt-til-punkt-integrasjoner skal avvikes i første avtaleår uten å redusere klinisk meldingskvalitet.	Integrasjonene grupperes etter risiko og volum. Hver migrering har kontrakttest, parallellkjøring, meldingsavstemming og godkjent tilbakefallsplan. Kilde og mål sammenlignes på antall, innhold, rekkefølge og kvitteringsstatus før gammel kobling stenges.
SOR-OBS-10	B	Observabilitet Drift og klinisk forvaltning bør ha separate, rollebeskyttede oversikter over flyt, forsinkelse, avvik og pasientsikkerhetskritiske hendelser.	Teknisk drift ser kødybde, feilrate og latenstid uten pasientinnhold. Klinisk forvaltning ser berørte forløp, prioritet og oppfølgingsstatus med nødvendig pasientkontekst. Varslingsgrenser og ansvar følger en avtalt driftsmatrise.
SOR-TEST-11	A	Verifikasjon Akseptansetesten skal dekke bortfall av nettverk, duplikate meldinger, forsinket kvittering, feil regelversjon, nødtilgang og full gjenoppretting.	Alle seks scenarioene kjøres i et produksjonslikt miljø med syntetiske pasienter. Forventet resultat, faktisk resultat, loggbevis og klinisk godkjenner registreres. Kritiske avvik blokkerer pilot.
SOR-INN-12	B	Innføring Leverandøren bør beskrive klinisk innføring for hjertesvikt og KOLS uten å øke uavklarte alarmer i vaktteamene.	Hvert forløp starter med regelverksted, simulering og stille pilot der varsler sammenlignes uten å styre behandling. Deretter åpnes et begrenset pasientutvalg med daglig sikkerhetsmøte før skalering. Alarmmengde, responstid og falske positive følges.

5. Posisjonering og dokumentert verdi

- Pasientsikkerhet gjennom rekonstruerbar beslutningskjede.
- Ingen tap av bekreftede kliniske meldinger.
- Kontrollert reduksjon av punkt-til-punkt-kompleksitet.
- Klinisk innføring som måler alarmbelastning, ikke bare teknisk tilgjengelighet.

6. Forutsetninger og leveranserisiko

- Ukjent EPJ-grensesnitt kan påvirke plan og estimat.
- Uavklart plassering av kliniske regler kan skape dobbelt forvaltningsansvar.
- Spennet i pasientvolum kan påvirke kapasitet og bemanning.

Ingen skjulte avvik

De åpne forholdene i Bilag 1 håndteres som beslutningspunkter. Leverandøren har ikke lagt uavklarte opsjoner til grunn for at basisløsningen skal fungere.